

- משכיבים את המטופלת על צידה השמאלי
- מנטרים סימנים חיוניים לאורך כל הטיפול והפינוי

לחץ דם נמוך בשכיבה

כשהאישה מתקרבת לסוף ההיריון היא נושאת משקל כבד הכולל את משקל הרחם, העובר והשליה. משקל זה, כשהאישה שוכבת על גבה, לוחץ על הווריד הנבוב התחתון ומונע חזרה ורידית תקינה ללב.

התוצאה: ירידה של 30%-40% מתפוקת הלב.

- נפח כלי הדם הוא מלכתחילה גבולי ויש להיזהר, לכן בכל מקרה של השכבת האישה לצורך בדיקה או פינוי יש להשכיבה על צידה השמאלי כי ה־vena cava נמצא בצד ימין.
- אם לחץ הדם ממשיך לרדת יש חשד להלם ויש להמשיך טיפול כנדרש.

סוכרת היריון

אישה הרה שמאובחנת כסוכרתית בדרך כלל משתייכת לאנשים עם סוכרת סמויה, כלומר הייתה לה סוכרת לפני ההיריון או התפתחה במהלכו.

- הסוכרת בדרך כלל אינה מתגלה בבדיקת שתן.
- סוכרת היריון עלולה לגרום לפגיעה ולמומים ביילוד.
- לעובר מערכת איזון סוכר משלו, אך את הסוכר הוא מקבל מהאם; מכאן שאם לאם יש סוכרת אין פירוש הדבר שלעובר תהיה סוכרת.
- אצל נשים חולות סוכרת בדרך כלל מתפתחים ולדות גדולים מהרגיל (מעל 4.5 ק"ג), ולכן במקרים מסוימים מקדימים את הלידה סמוך לשבוע ה־36.
- לתינוקות אלה, למרות גודלם, יש בדרך כלל מאפיינים של פג.
- תופעה שכיחה אצל תינוקות אלה היא שמייד לאחר הלידה מתפתחת אצלם היפוגליקמיה, העלולה להימשך 24-72 שעות, והיא חולפת בהדרגה. יש למנוע היפוגליקמיה על ידי מעקב ומתן גלוקוז.
- על האישה לשמור על איזון הסוכר בדמה ולהשתדל לא להיות עם רמת סוכר גבוהה.

לידה

סוגי לידות

- (1) היריון במועד - היריון המסתיים בשבועות 37-42
- (2) לידה - יציאה שלמה של עובר שמשקלו 500 גרם ויותר או תינוק עם סימני חיים
- (3) לידה מוקדמת - לידה לפני תום שבוע 37 להיריון
- (4) פג - תינוק שנולד לפני תום השבוע ה־37 להיריון

לידה מוקדמת

לידה שמתרחשת לפני תום השבוע ה־37 נחשבת ללידה מוקדמת. שכיחותה: 3%-10% מהלידות.

הסיבות ללידה מוקדמת

- רובן לא ידועות
- פקיעה מוקדמת של הקרומים (זיהום)
- אי־ספיקה צווארית
- מומים מולדים
- תת־משקל ותת־תזונה
- מאמצים פיזיים קשים
- עישון
- היריון מרובה עוברים
- יתר לחץ דם (יל"ד)
- מחלות כליה ומחלות לב־ריאות
- היפרדות השליה
- שליית פתח
- אנומליה של הרחם

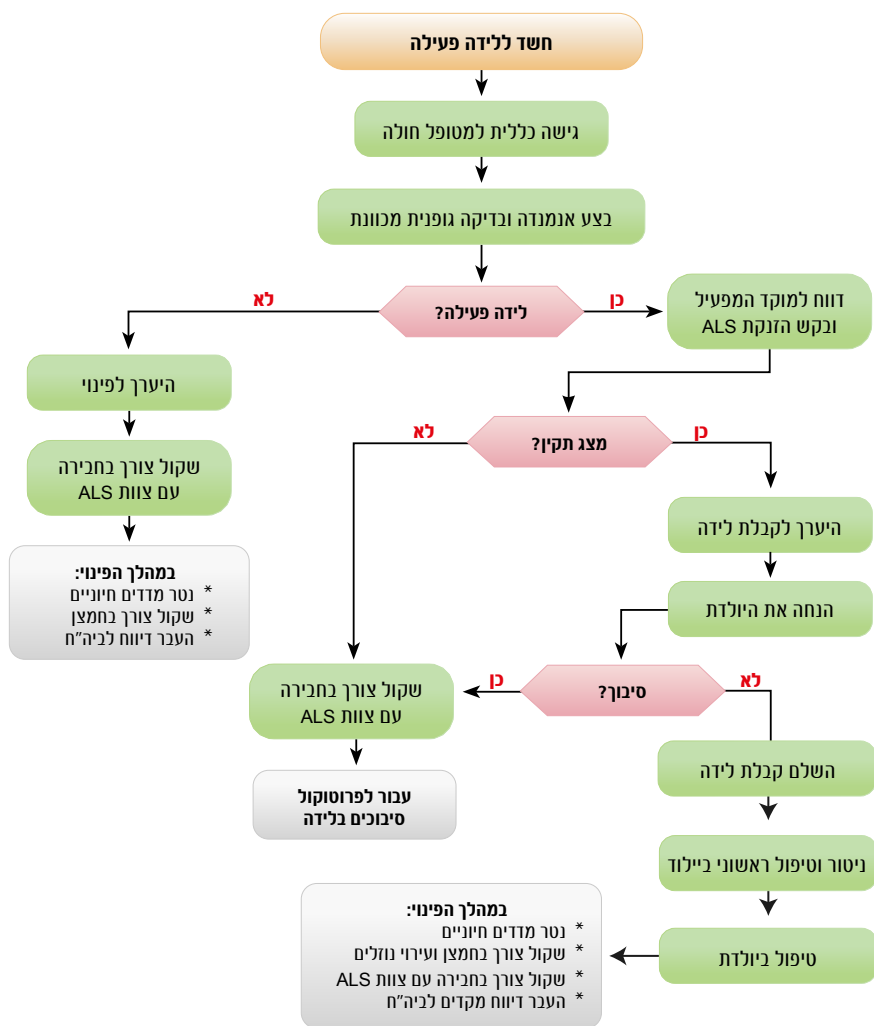
סימנים וסימפטומים

- התכווצויות רחמיות
- הפרשות מהנרתיק, דימומים
- דליפת מי שפיר

הטיפול

- מפנים לבית החולים המתאים (מרכז פגים) ומודיעים מבעוד מועד
- חוברים לנט"ן בהתייעצות עם מוקד מרחבי
- נותנים חמצן דרך מסכה
- משכיבים את היולדת על צידה השמאלי
- מנטרים סימנים חיוניים
- אם תתרחש לידה בדרך לבית החולים יש לעצור בצד הדרך ולקבלה (תרשים 16.1).

קבלת לידה



דגשים:

<u>לפי ובמהלך הלידה</u> * הגן ציוד נדרש לקבלת לידה, טיפול ביולד וטיפול ביולדת. * דאג לסביבה נקייה, טוהר ומחוממת ושומר על צנעת היולדת ככל הניתן. * הנחה את היולדת לכיבוץ מתאמות עם הציירים. * שקול כיצוד בשקט לילול במקרה של מים מקוואליים. <u>סיובים נפוצים (פרוטוקול נפרד)</u> * מצב חריג (עכוז, נפח, רוחני) * פרע כתמים/לידה שאינה מתקדמת * שמש חבל הטבור * חבל טבור כרוך סביב צוואר הילוד	<u>לידה פעילה</u> * צירים סדירים וארוכים * לחץ חזק באיזור הפריאנום * דחף חזק לכיבוץ לחיצות * Crowning <u>לידה חבירה עם צוות ALS</u> * זמן ומרחק מביה"ח * סיכון צפוי או שהפתח במהלך הלידה. * צורך בטיפול מיוחד בילוד או כאם לאחר הלידה	<u>אנמנזה</u> * גיל ההריון * לילות בעבר (לרבות מקדמות) * ניתוח קיסקי בעבר * מעקב קריין - סיכונים ידועים (כגון: סוכרת, רעלת וכד') * מספר עוברים? מנח? * תדירות ומשך הציירים * יריות מים? מים מקוואליים? דימום וגינאלי?
--	--	--

תרשים 16.1 תרשים זרימה של פרוטוקול קבלת לידה